



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : ساميه احمد رشوان عبد الخالق

العنوان : عماره 14 منطقه

3 شركه مصر للتعمير مصر

الجديده القاهره

الحي / المدينة : مصر الجديده

المحافظة : القاهره

تاريخ تسجيل الإستماره : 24-09-2026

رقم البطاقه : 24901270100528 رقم التليفون : 01008281074

العمر(تاريخ الميلاد) : 27-01-1949 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة

قسم العلاج :
الأورام

[11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة



الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /----- /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :

قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ساميه احمد رشوان عبد الخالق National ID: 24901270100528	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

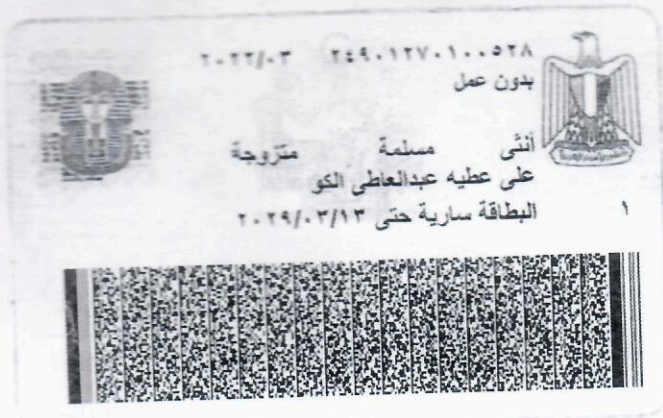
التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



١٠٠٨٢٨١.٧٤
 ماحو + ٥
 عيسى

١٢٣٥١٥٥٣٠

١٠٩٦٧٤٩١٤



رقم الطلب فتح رفع العيب
 ناقص الاشعة

٦٧٤٦١٩١٣
 تاريخ التنفيل ١٨ / ١٨ - ٢٠٢٩

الاسم: صفاء عبد الوافي التاربية
الرقم القومي: ٢٨٠٥١٠٠٤٩٦٠١٢٧٤
رقم التليفون: ٣٨١٢٧٤

مستهدفة بالتوعية
مستهدفة بالتوعية والفحص الإكلينيكي

قياس ضغط	قياس السكر العشوائي	مؤشر كتلة الجسم	الطول	الوزن
				90

* فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً

مارس 2026			2026	فبراير		يناير 2026
يونيو 2026			2026	مايو		أبريل 2026
سبتمبر 2026			2026	أغسطس		يوليو 2026
ديسمبر 2026			2026	نوفمبر		أكتوبر 2026
مارس 2027			2027	فبراير		يناير 2027
يونيو 2027			2027	مايو		أبريل 2027
سبتمبر 2027			2027	أغسطس		يوليو 2027
ديسمبر 2027			2027	نوفمبر		أكتوبر 2027

حافظ، علي، قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.

إذا كنت قد سبق الزواج أو الانجاب، استشري طبيب تنظيم الأسرة.

- اطمئني ، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

توقيع الطبيب:

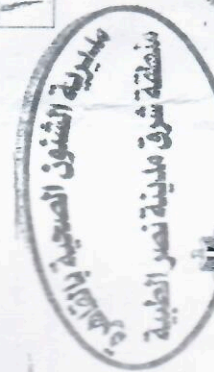
معد التقييم: المكان المحولة له للتقييم:

15335

www.100millionseha.eg

سید احمد علی

27/8/14



منظمة
الصحة العالمية
جمهورية مصر العربية

مجلس إدارة
مجلس إدارة

مجلسه اول

البريد - بغداد

مصر
صحيفة
السياسة المصرية



رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2026-8-16

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) ساميه احمد رشوان عبدالخالق بطاقة رقم 24901270100528
تليفون رقم: 01008281074

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

تاريخ الطباعة : 2026-8-16

الموظف المختص

محمود عبدالله



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2051062



الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

007848

اسم المريض بالإنجليزية: samia Ahmed Rashwan Abdalkhalek	كود المريض: 98457
تاريخ التقرير: 2026/08/16 12:42:39 PM	السن: ٧٧ سنة, ٦ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 77 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 UOQ ill-defined spiculated dense mass lesion measures about 3.5 x 3.3 cm at its maximum diameters with architectural distortion and about 9.5 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined hypoechoic mass lesion and located at 10 ° clock position measuring about 30 x 27 mm and associated with minimal overlying skin dimpling measures about 3.3 mm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III some of them show focal cortical thickening while the others showing effaced hila, largest one measures about 8.6 x 6 mm at level III.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5):** Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. Tru cut biopsy was done on the same setting.
- **Left breast (BIRADS 2):** Normal study.

*Much obliged,
Dr. Hedaya Nour, MD*



جمهورية مصر العربية
بطاقة تعقيم الشخصية

ساميه

احمد رشوان عبدالخالق

عمارة ١٤ - منطقة ٣ - شركة مصر للتعمير

مصر الجديدة - القاهرة

١٩٤٩/٠٧



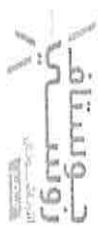
٢٤٩٠١٢٧٠١٠٠٥٢٨

JH2522517





Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي القى رنشنال - مصر معمل الباثولوجى



Patient Name	سالمىه احمد رشنال	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 10 O'clock UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 11:30 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.3 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 40%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 3.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 40%.



خريطة رقم (44) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القومية - القاهرة 3 - مصر
Room No. (44) - First Floor- Building No. 987- Nile Corniche - Mike El Qadema - Cairo, Egypt



Gustave Roussy International-Egypt Pathology Lab
جوستاف روسي للسرطان - مصر - مصر



Patient Name	سالمية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - قسم تشخيص النخاع - مصر (القاهرة 5 - مصر)
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Alsar El Qadema - Cairo, Egypt

الاسم المرضي بالخطيرة : samia Ahmed Rasthwan Abdalkhalek	كود المرضي : 98457
تاريخ التقرير : 2026/08/16 12:42:39 PM	السن : ٧٧ سنة ، ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 77 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 UOQ ill-defined spiculated dense mass lesion measures about 3.5 x 3.3 cm at its maximum diameters with architectural distortion and about 9.5 cm from the nipple.
- Ultrasound revealed ill-defined hypoechoic mass lesion and located at 10 ° clock position measuring about 30 x 27 mm and associated with minimal overlying skin dimpling measures about 3.3 mm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III some of them show focal cortical thickening while the others showing effaced hila, largest one measures about 8.6 x 6 mm at level III.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. Tru cut biopsy was done on the same setting.
- Left breast (BIRADS 2): Normal study.

Much obliged,
Dr. Hedaya Nour, MD

جمهورية مصر العربية
بطاقة تعقيم الشخصية

ساميه
احمد رشوان عبد الخالق

عمارة ١٤ - منطقة ٣ - شركة مصر للتعمير
مصر الجديدة - القاهرة

١٩٤٩/٠٧
٢٤٩٠١٢٧٠١٠٠٥٢٨

JH2522517



Patient Name	سامية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 10 O'clock UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 11:30 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.3 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 40%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 3.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 40%.



خريطة رقم (44) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة 3 - مصر
 Room No. (44) - First Floor- Building No. 987- Nile Corniche - Mike El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	سامية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.


خريطة رقم (4) - الجوز - الجوز - مبنى رقم (987) - مبنى رئيسي النيل - مصر - القاهرة 5 - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Alsar El Qadema - Cairo, Egypt

سامية أحمد راشد عبد الخالق : اسم المريض بالإنجليزية	98457 : كود المريض
2026/08/16 12:42:39 PM : تاريخ التقرير	السن : ٧٧ سنة ، ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 77 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 UOQ ill-defined spiculated dense mass lesion measures about 3.5 x 3.3 cm at its maximum diameters with architectural distortion and about 9.5 cm from the nipple.
- Ultrasound revealed ill-defined hypoechoic mass lesion and located at 10 ° clock position measuring about 30 x 27 mm and associated with minimal overlying skin dimpling measures about 3.3 mm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III some of them show focal cortical thickening while the others showing effaced hila, largest one measures about 8.6 x 6 mm at level III.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. Tru cut biopsy was done on the same setting.
- Left breast (BIRADS 2): Normal study.

*Much obliged,
Dr. Hedaya Mour, MD*

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ساميه
احمد رشوان عبد الخالق

عمارة ١٤ - منطقة ٣ - شركة مصر للتعمير
مصر الجديدة - القاهرة

١٩٤٩/٠٧
٢٤٩٠١٢٧٠١٠٠٥٢٨

JH2522517



Patient Name	سامية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 10 O'clock UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 11:30 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.3 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 40%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 3.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 40%.



Patient Name	سامية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.


خريطة رقم (4) - الجوز - الجوز - مبنى رقم (987) - مبنى رئيسي النيل - مصر - القاهرة 5 - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Alsar El Qadema - Cairo, Egypt

سامية أحمد راشد عبد الخالق : اسم المريض بالإنجليزية	98457 : كود المريض
2026/08/16 12:42:39 PM : تاريخ التقرير	السن : ٧٧ سنة ، ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 77 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 UOQ ill-defined spiculated dense mass lesion measures about 3.5 x 3.3 cm at its maximum diameters with architectural distortion and about 9.5 cm from the nipple.
- Ultrasound revealed ill-defined hypoechoic mass lesion and located at 10 ° clock position measuring about 30 x 27 mm and associated with minimal overlying skin dimpling measures about 3.3 mm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III some of them show focal cortical thickening while the others showing effaced hila, largest one measures about 8.6 x 6 mm at level III.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. Tru cut biopsy was done on the same setting.
- Left breast (BIRADS 2): Normal study.

*Much obliged,
Dr. Hedaya Mour, MD*

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ساميه
احمد رشوان عبد الخالق

عمارة ١٤ - منطقة ٣ - شركة مصر للتعمير
مصر الجديدة - القاهرة

١٩٤٩/٠٧
٢٤٩٠١٢٧٠١٠٠٥٢٨

JH2522517



Patient Name	سامية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 10 O'clock UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 11:30 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.3 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 40%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 3.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 40%.



Patient Name	سالمية احمد رشوان	Case No.	358700
Sex/Age	Female 77 Y	Patient No.	26003
Registered Date	17/8/2026 02:31:27 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:17:00 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	13/9/2026 12:02:51 PM	Pathology No.	2618/26

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.


خريطة رقم (4) - الجوز - الجولي - مستشفى رقم (987) - قصر رئيس النيل - مصر - القاهرة 5 - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Alsar El Qadema - Cairo, Egypt

سامية أحمد رشيد عبد الخالق : اسم المريض بالإنجليزية	98457 : كود المريض
2026/08/16 12:42:39 PM : تاريخ التقرير	السن : ٧٧ سنة ، ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 77 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 UOQ ill-defined spiculated dense mass lesion measures about 3.5 x 3.3 cm at its maximum diameters with architectural distortion and about 9.5 cm from the nipple.
- Ultrasound revealed ill-defined hypoechoic mass lesion and located at 10 ° clock position measuring about 30 x 27 mm and associated with minimal overlying skin dimpling measures about 3.3 mm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III some of them show focal cortical thickening while the others showing effaced hila, largest one measures about 8.6 x 6 mm at level III.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. Tru cut biopsy was done on the same setting.
- Left breast (BIRADS 2): Normal study.

*Much obliged,
Dr. Hedaya Mour, MD*